

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR LEBEN UND WERDUNG
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 27	Bezeichnung des Dokumentes: „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“, in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard, 1. Aktualisierung 2015	

Durchführende:

Pflegefachkräfte (PFK)

Pflegeziel:

- Jeder Patient mit einer chronischen Wunde vom Typ Dekubitus, Ulcus cruris venosum/arteriosum/mixtum oder Diabetischem Fußulcus erhält eine pflegerische Versorgung, die das individuelle Krankheitsverständnis berücksichtigt, die Lebensqualität fördert, die Wundheilung unterstützt und Rezidivbildung von Wunden vermeidet.

Der hier vorliegende Standard schließt auch die Versorgung von Menschen mit **akuten Wunden** ein. Diese sind gekennzeichnet durch kurze Heilungsdauer und i. d. R. komplikationslosen Heilungsverlauf. Beispiele für akute Wunden sind OP-Wunden, Schnitt- oder Platzwunden, Verbrennungen usw.

Indikation:

- bei Vorliegen eines Dekubitus
- bei Vorliegen eines Ulcus cruris venosum, Ulcus cruris arteriosum, Ulcus cruris mixtum
- bei Vorliegen eines Diabetischen Fußulcus

Kontraindikation:

- bei Ablehnung durch den Patienten

Festlegungen zur pflegerischen Fachexpertin (PFE):

- unser Pflegedienst wird durch eine externe PFE unterstützt, die/der Mitarbeiter/-in ist Angestellte bei der Firma: Durch die Firma ist die „Erklärung zur Anerkennung, Berücksichtigung und Umsetzung des Nationalen Expertenstandards Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“ zu unterzeichnen.
- in unserem Pflegedienst ist Frau / Herr: als interne PFE eingesetzt, diese verfügt über die geforderte Ausbildung sowie die nötigen Fertigkeiten gemäß dem Nationalen Expertenstandard

Vorbereitung:

- Hände waschen, Händedesinfektion
- Patienten informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

Material:

- Verbandsmaterialien
- u. U. Lagerungsmaterialien, z.B. Kissen, Lagerungsschienen, Schalen, Polster
- u. U. Kompressionsstrümpfe etc.
- notwendige Formulare

Durchführung:

- Jede PFK hat Menschen mit den o.g. chronischen Wunden besonders zu beachten.
- Patienten mit diesen schweren chronischen Wunden benötigen nicht nur eine dem neuesten Stand pflegerisch-medizinischer Entwicklung entsprechende Wundversorgung, sondern aus ganzheitlicher Sicht auch der sozialen Betreuung, Weiterbildung und Aufklärung. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten ist zu beachten, bei Einbindung von Angehörigen ist vorher die Genehmigung durch den Patienten einzuholen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR LEBEN UND WUNDEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 27	Bezeichnung des Dokumentes: „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“, in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard, 1. Aktualisierung 2015	

- die erste pflegefachliche Einschätzung (bei Aufnahme) zu wund- und therapiebedingten Einschränkungen sowie der Selbstmanagementkompetenzen des Patienten und Angehörigen erfolgt durch die PFK bei Vorliegen einer der o.g. chronischen Wunden und wird als Situationseinschätzung in den Themenfeldern in der „Strukturierten InformationsSammlung“ (SIS) festgehalten.

Kriterien zur Einschätzung der wund- und therapiebedingten Einschränkungen sowie der Selbstmanagementkompetenzen von Patienten/Angehörigen:

1. Verständnis des Krankseins

- zu Ursachen der Wunde
- zur Heilung der Wunde und Vorstellungen zur Wundheilungszeit
- zu Symptomen (z.B. Geruch, Exsudat, Juckreiz)
- zur Bedeutung spezieller Maßnahmen (z.B. Druckentlastung, Bewegung, Kompression)

2. Welche Aussagen trifft der Patient zu wund- und therapiebedingten Einschränkungen

- Schmerzen (Stärke, Schmerzqualität, Häufigkeit und Dauer, Situationen, die mit Schmerzen einhergehen, Schmerzort und Erfahrungen mit der Linderung)
- Mobilitäts- und Aktivitätseinschränkungen
- Schlafstörungen
- psychosoziale Aspekte (z.B. soziale Isolation, Machtlosigkeit, Energiemangel, Sorgen, Frustrationen, Mangel an Selbstwertgefühl, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Depression, Gefühl des Kontrollverlustes)
- Abhängigkeit von personeller Hilfe
- Jucken und Schwellungen der Beine
- Schwierigkeiten bei Kleidungs- und Schuhwahl
- Schwierigkeiten zur Aufrechterhaltung der persönlichen Hygiene

3. Vorhandene wundbezogene Hilfsmittel (z.B. Kompressionsstrümpfe, spezielle Schuhe, Orthesen, druckverteilende Matratzen, Sitzkissen)

4. Selbstmanagementkompetenzen von Patienten und Angehörigen

- zum Umgang mit Einschränkungen (siehe oben)
- zur Wunde und zum Verbandwechsel (z.B. Wundgeruch, Schmerzen beim Verbandwechsel)
- Erhalt von Alltagsaktivitäten (z.B. Einkaufen, Hobbys, Spazieren gehen)
- krankheitsspezifische Maßnahmen
 - Entstauende Maßnahmen
 - Kompression (An-/Ausziehen, Pflegen, Umgang mit kompressionsbedingten Beschwerden)
 - Aktivierung des Sprunggelenks und der Muskelpumpe
 - Hochlegen der Beine über Herzniveau
 - Sitzposition
 - Gefäßtraining z.B. strukturiertes Gehtraining
 - Fußpflege und -inspektion

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR LEBENS- UND WUNDVERSORGUNG
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 27	Bezeichnung des Dokumentes: „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“, in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard, 1. Aktualisierung 2015	

- präventive Maßnahmen bei Diabetischem Fußulcus, z.B. Fußpflege, -inspektion, Umgang mit Schuhen
 - Druckentlastung der Wunde
 - Hilfsmittel (z.B. Orthesen, Matratzen, Kissen, (Verband-Schuhe), ggf. mit speziellen Einlagen zur Druckentlastung
 - Bewegungsförderung/Positionswechsel
 - Hautschutz, Hautpflege
 - Ernährung
 - Blutzuckereinstellung
 - Raucherentwöhnung
-
- tritt eine der o.g. chronischen Wunden später neu hinzu, erfolgt die Information an den Arzt, eine Eintragung im Pflegebericht und die Anpassung der Maßnahmenplanung
 - ist eine Beratung erfolgt, wird dies inhaltlich kurz im zutreffenden Themenfeld beschrieben, später notwendig werdende Beratungen sind im Pflegebericht festzuhalten
 - grundsätzlich dient der Pflegebericht zur Erfassung veränderter pflegerischer Situationen als anlassbezogene Evaluation in akuten Situationen oder bei besonderen Ereignissen oder Veränderungen
 - Liegen Anzeichen für der o.g. Wunden vor, ist die PFE einzubeziehen und der Arzt zur Diagnosestellung und zur Festlegung therapeutischer Maßnahmen heranzuziehen
 - Unser Pflegedienst bleibt hauptverantwortlich für die Wundversorgung, auch wenn Dritte (bspw. Wundschwestern, Wundmanager oder PFE) einbezogen werden
 - Bei Vorhandensein von Hautrötungen ist der Fingertest zur Feststellung eines Dekubitus Kategorie I anzuwenden.
 - Liegt ein Dekubitus vor, so ist der Entstehungszeitraum sofort zu dokumentieren (bspw. nach Krankenhausentlassung, bei Neuaufnahme, während unserer Betreuung mit Begründung).
 - Folgende Wundklassifikationen sind zur Bewertung der o.g. chronischen Wunden unter Einbeziehung der PFE anzuwenden:

Art der Wunde	Wundklassifikation
Dekubitus	• EPUAP 2014 • Bei der Bewertung eines Dekubitus gemäß EPUAP ist immer die höchste Kategorie zu ermitteln, im Rahmen der Abheilung bleibt diese Kategorie feststehend (bspw. abheilender Dekubitus Kategorie 4)
Ulcus cruris	• Ulcus cruris arteriosum nach Fontaine • chronisch venöse Insuffizienz nach Widmer
Diabetisches Fußsyndrom	• Wagner/Armstrong 1981/1998

- Die **Maßnahmen zur Wundversorgung und zur Verbesserung der Lebensqualität** sind in die Pflegeplanung aufzunehmen, alle 4 Wochen zu evaluieren und haben sich an der jeweiligen Wundart zu orientieren.
- Durch die PFK sind umgehend die notwendigen Heil- und Hilfsmittel einzusetzen.
- Die PFK trifft Maßnahmen zum Umgang und zur Vermeidung von wund- und therapiebedingten Beeinträchtigungen (Schmerzen, Mobilitätseinschränkungen, Wundgeruch, verstärktes Wundexsudat).

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN MIT PATIENTEN ZUSAMMEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 27	Bezeichnung des Dokumentes: „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“, in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard, 1. Aktualisierung 2015	

- Bei vorliegendem Diabetes sollte der Patient in regelmäßigen Abständen soweit möglich zur Inspektion der Füße motiviert werden.
- Die Wundversorgung erfolgt gemäß der Festlegung des Arztes und in individuell abgestimmten Zeiträumen, die Begutachtung des Heilungsfortschritts erfolgt durch den Arzt.
- Die PFE ist den PFK im Rahmen der Wundversorgung fachlich weisungsbefugt, sie stimmt sich mit den Mitarbeitern zum gemeinsamen Vorgehen ab.
- Die PFK setzen die Wundversorgung um, dies beinhaltet insbesondere Infektionsprävention und -bekämpfung, das Debridement (ohne chirurgisches), die Wundreinigung und das Anlegen der Wundauflagen.
- Die Anforderungen an Hygiene und Desinfektion im Rahmen der Wundversorgung sind zwingend einzuhalten und umzusetzen.

Festlegungen zur Wunddokumentation:

- Für jede Wunde ist 1 Wunddokumentationsbogen, chronische Wunden anzulegen.
- Die Dokumentation des Wundzustandes hat durch PFK in Zusammenarbeit mit der PFE bspw. nach dem Entfernen von avitalem Gewebe (Debridement), bei akuten Veränderungen, nach jedem Verbandwechsel bzw. mindestens alle 7 Tage zu erfolgen
- Zur Bewertung des Heilungsverlaufes bzw. Wundveränderungen können Fotos gefertigt werden. Der Patient hat hierzu eine Einwilligungserklärung nach § 201 a StGB zu unterzeichnen, wird das Fotografieren durch den Patienten abgelehnt, ist die Wunde zu beschreiben.
- Wundfotos sind in monatlichen Abständen anzufertigen. Soweit möglich sind folgende Dinge zu beachten: vorher die Wunde spülen, gleiche Lichtverhältnisse, gleicher Abstand zum Objekt, Wunde soll mindestens 1/3 des Fotos einnehmen, gleicher Mitarbeiter, der fotografiert, Anlegen von Messmitteln ohne die Wunde zu verdecken, der Name des Patienten und das Datum müssen erkennbar sein (Wundfotos ersetzen eine Beschreibung der Wunde nicht.).

Nachbereitung:

- Händedesinfektion
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL
- bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	4	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE AM LARZKUNSTZENTRUM
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 27	Bezeichnung des Dokumentes: „Pfleger von Menschen mit chronischen Wunden“, in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard, 1. Aktualisierung 2015	

**Erklärung zur Anerkennung, Berücksichtigung und Umsetzung des
Nationalen Expertenstandards „Pfleger von Menschen mit chronischen Wunden“
für Mitarbeiter externer Anbieter**

Bezeichnung des externen Anbieters der die Wundversorgung des Dekubitus, Ulcus cruris und Diabetischen Fußulcus für unseren Pflegedienst absichert:

(Bezeichnung/Adresse)

Hiermit erkläre ich im Namen des vorgenannten Anbieters, dass:

- unsere Mitarbeiter über die nötigen Kenntnisse zur Umsetzung des Nationalen Expertenstandards „Pfleger von Menschen mit chronischen Wunden“ (Stand 2015) verfügen. Ein Nachweis der empfohlenen Fortbildung liegt bei.
- unsere Mitarbeiter den Nationalen Expertenstandard „Pfleger von Menschen mit chronischen Wunden“ Stand 2015 anerkennen.
- unsere Mitarbeiter den Nationalen Expertenstandard „Pfleger von Menschen mit chronischen Wunden“ Stand 2015 in der Praxis tatsächlich anwenden und
- unsere Mitarbeiter vor Ort mit ihren Mitarbeiter zielstrebig an der Verbesserung der Lebensqualität und der ordnungsgemäßen Wundversorgung ihrer Patienten arbeiten.

Uns ist bekannt, dass die Umsetzung des Nationalen Expertenstandards „Pfleger von Menschen mit chronischen Wunden“ eine gesetzliche Aufgabe des Pflegedienstes im Sinne der §§ 112 ff. SGB XI ist. Eine Verletzung dieser Erklärung kann zur Lösung des Vertragsverhältnisses, verbunden mit Schadensersatzforderungen führen.

Ort: Datum:

.....
Unterschrift/Stempel

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	5	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE AM KLINIKUM
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 27	Bezeichnung des Dokumentes: „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“, in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard, 1. Aktualisierung 2015	

Informations- und Beratungsblatt „Aufklärung zu Dekubitus“

Name, Vorname des Patienten:	Name, Vorname des Angehörigen/Betreuers:
-------------------------------------	---

Allgemeine Schulungs- und Beratungsinhalte sind:

- Wundursache und zeitliche Erwartungen zur Wundheilung
- die Vermeidung thermischer, chemischer und mechanischer Traumata (Verletzungen)
- Bedeutung von Schmerz und Exsudat
- sachgerechte Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Wundheilung bspw. Nutzung steriler Verbandstoffe
- wirksame Hautpflege

Zusätzliche Informationen und Beratung beinhalten:

- Bewegungsförderung
- Umgang mit druckreduzierenden und druckverteilenden Hilfsmitteln
- Lagerung, Bewegung

Weitere wichtige Hinweise:

Datum		Unterschrift Patient/Betreuer/ Bevollmächtigter/ Angehöriger		Unterschrift Pflegefachkraft		
Datum		Unterschrift Patient/Betreuer/ Bevollmächtigter/ Angehöriger		Unterschrift Pflegefachkraft		
		Unterschrift Patient/Betreuer/		Unterschrift		
Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	6	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR LEBEN UND WERTSCHAFTUNG
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 27	Bezeichnung des Dokumentes: „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“, in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard, 1. Aktualisierung 2015	

Datum		Bevollmächtigter/ Angehöriger		Pflegefachkraft	
Datum		Unterschrift Patient/Betreuer/ Bevollmächtigter/ Angehöriger		Unterschrift Pflegefachkraft	

Informations- und Beratungsblatt „Aufklärung zu Diabetischem Fußulcus“

Name, Vorname des Patienten:	Name, Vorname des Angehörigen/Betreuers:

Allgemeine Schulungs- und Beratungsinhalte sind:

- Wundursache und zeitliche Erwartungen zur Wundheilung
- die Vermeidung thermischer, chemischer und mechanischer Traumata (Verletzungen)
- Bedeutung von Schmerz und Exsudat
- sachgerechte Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Wundheilung bspw. Nutzung steriler Verbandstoffe
- Umgang mit Beschwerden, wie geschwollene Beine oder Schmerzen, bedarfsgerechte Ernährung
- wirksame Fußpflege
- die mögliche Vermittlung von Selbsthilfegruppen zur Raucherentwöhnung, Sportgruppen (Venengymnastik), Diabetes

Zusätzliche Informationen und Beratung beinhalten:

Diabetischer Fußulcus

- Fuß- und Schuhinspektion zur Vermeidung und Erkennen von Verletzungen
- sachgerechtes Tragen von druckentlastenden orthopädischem Schuhwerk
- Fußpflege
- Gehschule zur Vermeidung von Stürzen
- Raucherentwöhnung

Weitere wichtige Hinweise:

Datum		Unterschrift Patient/Betreuer/ Bevollmächtigter/ Angehöriger		Unterschrift Pflegefachkraft		
Datum		Unterschrift Patient/Betreuer/ Bevollmächtigter/ Angehöriger		Unterschrift Pflegefachkraft		
Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	8	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR LANGE WACHSCHATTEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 27	Bezeichnung des Dokumentes: „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“, in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard, 1. Aktualisierung 2015	

Datum		Unterschrift Patient/Betreuer/ Bevollmächtigter/ Angehöriger		Unterschrift Pflegefachkraft	
Datum		Unterschrift Patient/Betreuer/ Bevollmächtigter/ Angehöriger		Unterschrift Pflegefachkraft	

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	9	Verw./MA